

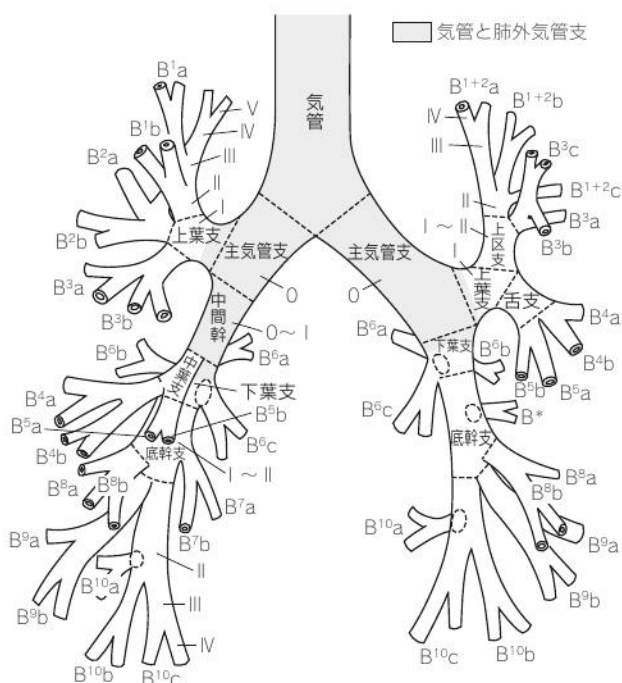


図1 気管支分岐と分岐次数

主気管支
 中間気管支幹(中間幹)
 上葉気管支(上葉支), 中葉気管支(中葉支), 下葉気管支(下葉支)
 上区気管支(上区支), 舌区気管支(舌支), 底幹気管支(底幹支)
 区域支
 亜区域支
 亜々区域支

0次
 0~1次
 1次
 1~11次
 11次———B¹
 11次———B¹a B¹b
 11次———B¹ai B¹aii
 11次———B¹aiα B¹aiβ
 11次———B¹aiαx B¹aiαy
 11次———B¹aiαxx B¹aiαxy

IV次, V次気管支の命名に関しては、既に命名されている亜区域支 a, b の分岐に準じて i, ii, および α, β と命名する。したがって、その気管支の分岐方向と分布領域からみて上方、後方または外側方のものを i あるいは α とし、下方、前方または内側方のものを ii あるいは β とする。VI次以降の分岐は x と y の2分岐で表し、V次気管支までの方法に準じて、上方、後方、外側方を x, 下方、前方、内側方を y として V次気管支に連続して表記する。

[日本肺癌学会(編), 臨床・病理 肺癌取り扱い規約, 第9版, 金原出版, p182, 2025より許諾を得て転載]
 本図は日本肺癌学会が作成したものであり、本図の内容に関するご質問・お問い合わせ等は、日本肺癌学会までご連絡ください。本書は、日本肺癌学会および発行元である金原出版株式会社からの許諾を得て、本図の内容を改変することなく転載し、使用しています。

2

直視下生検、擦過

direct vision biopsy and brushing

到達目標

- 直視下生検・擦過の目的と適応を概説できる
- 直視下生検・擦過の手技を説明できる
- 直視下生検・擦過の合併症を列挙できる

1 目的

直視下生検とは、気管支鏡で直接観察できる気管や中枢気管支における病変から組織診用の検体を採取す

ることで、主に生検鉗子や吸引針を用いて行われる。一方、擦過は細胞診用検体採取や病原微生物検出目的に、主にブラシを用いて行われる。

2 適応

気管支鏡で観察しうるほぼすべての気道内病変が直視下生検の適応である。しかし、血管性病変(動静脈瘤、動静脈奇形、動脈瘤や静脈瘤など)は著しい出血をきたすことがあり、生検は禁忌である。

3 手技の実際

a 気管支内生検(EBB)

気管支内生検(endobronchial biopsy: EBB)は、